

KC桌面——外资精译

世界银行：刚果金的WASH项目改善了设施，却未能减少儿童腹泻

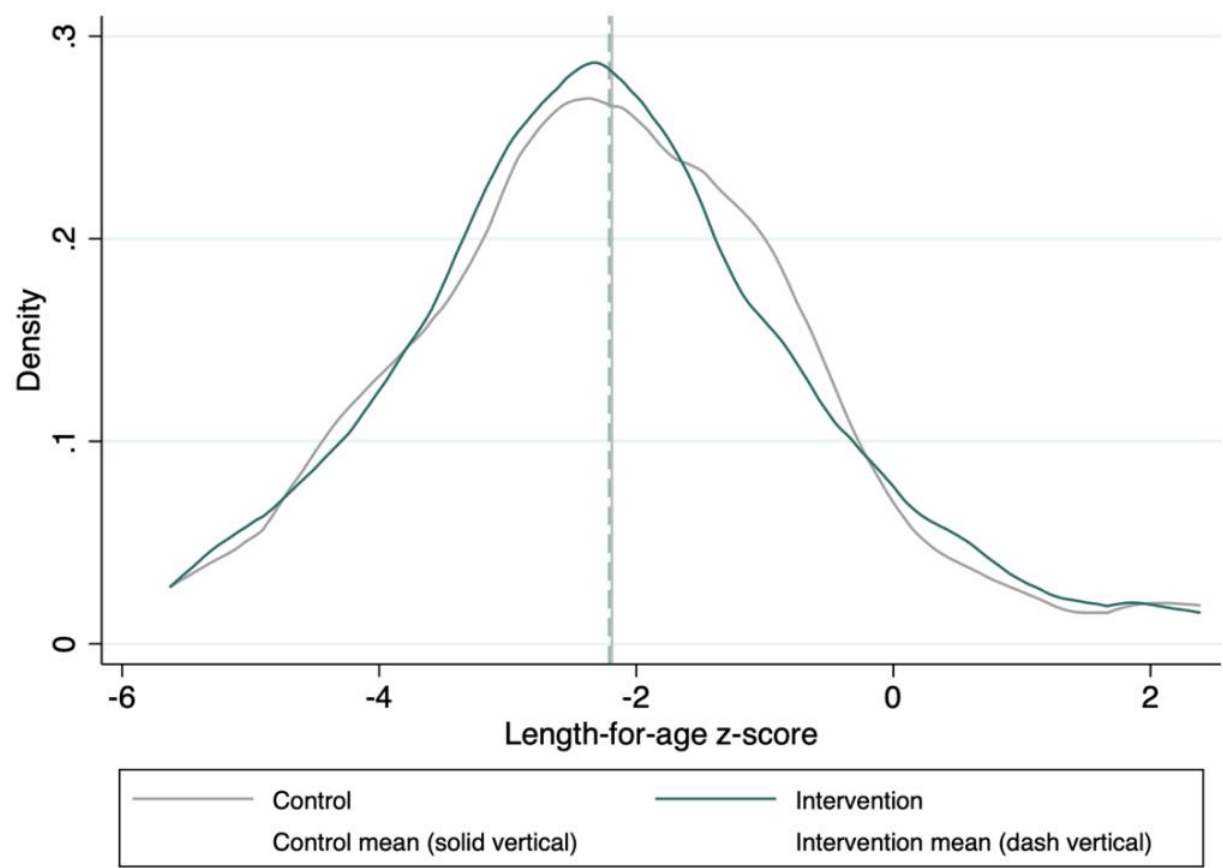
世界银行最新发布的一项随机对照试验评估了刚果民主共和国（DRC）全国性农村水、卫生与个人卫生（WASH）项目的实际效果。结论令人深思：项目确实建起了厕所、打了水井、成立了村委会，但三年半后，儿童腹泻率和发育迟缓指标并未改善。这为全球发展领域“基础设施投入是否必然带来健康改善”的核心争论提供了新证据。

基础设施和机构建设成效显著，但健康改善链条断裂

项目在硬件和制度建设上取得了明确成果。数据显示，干预组村庄在WASH机构指数上比对照组高出0.40个标准差，拥有活跃WASH委员会的村庄比例高出21个百分点。家庭层面，干预组使用改善水源的可能性高出24个百分点，使用改善卫生设施的可能性高出18个百分点。这些改善在项目结束三年半后仍然持续，说明社区主导模式在制度可持续性上表现不错。

然而，健康指标的改善并未随之而来。研究对3283户家庭进行了调查，发现干预对儿童腹泻患病率没有显著影响，对儿童年龄别身长Z评分（衡量发育迟缓的关键指标）也没有改善效果。这意味着，即便村民用上了更干净的水和厕所，儿童肠道健康的改善链条在刚果金的现实环境中断裂了。

> KC评论：这提醒我们，WASH项目的健康效益不是“建了就有效”。在高度贫困和冲突频发的地区，即便基础设施到位，日常卫生行为的持续改变、水源的持续安全、以及儿童营养状况的综合改善，才是真正降低腹泻的关键。



图表 1

行为改变与水质污染：被忽视的中间环节

研究揭示了健康链条断裂的可能原因。尽管项目包含行为改变宣传，但实际观察发现，干预组和对照组在关键卫生行为上差异有限。例如，在结构化观察中，干预组家庭在准备食物前洗手的比例并未显著高于对照组。更关键的是水质检测结果：虽然干预组家庭更可能报告使用“改善水源”，但实际检测显示，家庭储存水的微生物污染水平在两组间没有显著差异。

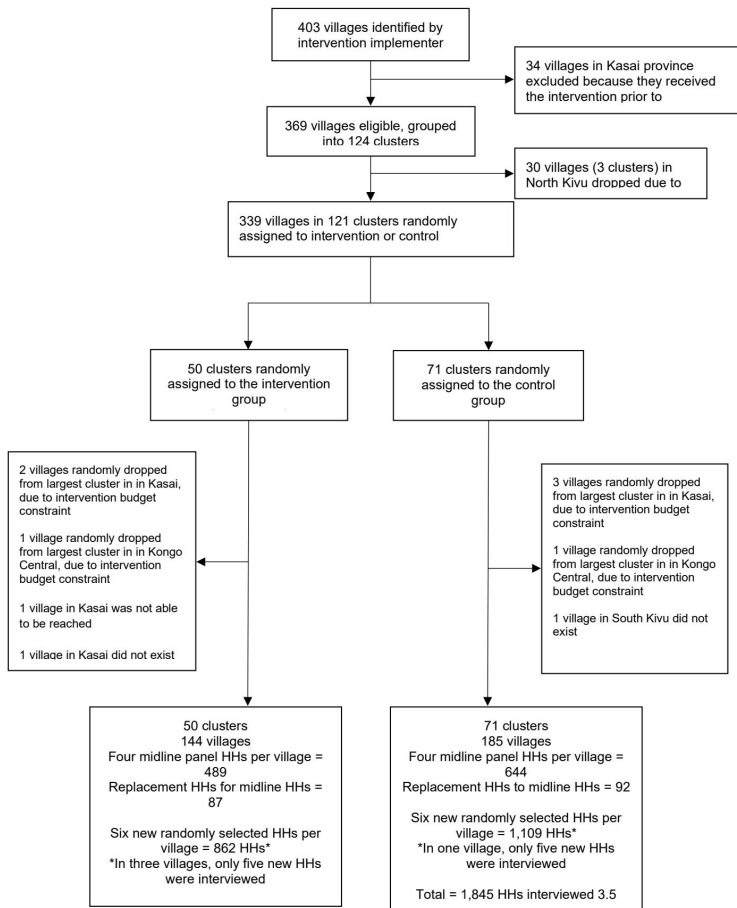
这说明，即便水源本身得到改善，从取水到家庭储存、再到使用过程中的二次污染，可能抵消了基础设施带来的健康收益。项目投入的约2000美元用于供水设施、2000美元用于卫生设施，但未能确保从水龙头到水杯的全程安全。

冲突环境下的WASH干预：效果有限但仍有政策启示

刚果金是全球WASH挑战最严峻的国家之一——截至2020年，仍有4800万人缺乏基本饮用水服务，7200万人缺乏基本卫生服务。项目在五个省份实施，其中北基伍省因安全原因甚至无法纳入试验。在这样的冲突环境中，项目能够实现基础设施和机构建设的持续改善，本身已属不易。

研究指出，这是首个评估“新机构创建+基础设施投资+行为改变宣传”组合干预效果的随机试验，且随访期长达3.6年，为政策制定者提供了在类似冲突环境中WASH干预的现实效果评估。但结果也明确显示，仅靠社区主导的WASH项目，不足以打破腹泻和发育迟缓的恶性循环。

> KC评论：对政策制定者而言，这意味着WASH项目需要更精细的设计。单纯追求“覆盖率”指标（如多少村庄有了水井、厕所）可能产生误导。真正的健康改善需要配套的水质监控、持续的卫生行为干预，以及更广泛的营养和医疗支持。刚果金的经验对非洲其他冲突地区同样具有警示意义。



图表 2

研究最终给出的核心政策启示是：WASH基础设施和机构建设是必要条件，但远非充分条件。在资源有限的发展环境中，如何将硬件投入转化为可测量的健康改善，仍是全球发展领域最棘手的挑战之一。